Oefententamen kwalitatief onderzoek (AB_1167).

Let op:

- Het antwoord model geeft voorbeelden van goede antwoorden. In sommige gevallen kunnen andere antwoorden ook juist zijn. Per antwoord kijken we of een student een logische argumentatie heeft, en gebruikt maakt van kennis en definities uit de leerstof.

1. GESCHIEDENIS

   Mortelmans gebruikt in hoofdstuk 2 de overzichten van Denzin, Lincoln en Flick om de ontwikkeling van de kwalitatieve methodologie in de tijd weer te geven. Welke van de onderstaande stellingen is niet waar? (1 punt)

   a. De Europese ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden is vooral gestoeld op werk uit Duitsland.
   b. De Amerikaanse traditie van kwalitatief onderzoek volgt de Europese traditie.
   c. Het in kaart brengen van de geschiedenis van kwalitatief onderzoek is ingewikkeld omdat er niet iets is dat we hét kwalitatief onderzoek kunnen noemen.
   d. Alle stellingen zijn niet waar

2. OPZET

   Wat kan over het algemeen NIET gegarandeerd worden bij het uitvoeren van kwalitatieve studies in het veld? (1 punt)

a. Anonimiteit garanderen in kleinere settings (een organisatie bijvoorbeeld)
b. Deelnemers waarschuwen dat er mogelijk fysieke en emotionele schade kan voorkomen in een informatiebrief
c. Geïnformeerde toestemming krijgen
d. Toestemmingsformulieren bijhouden

In de rest van het tentamen wordt er gebruik gemaakt van het artikel van Loukili et al. (2024), getiteld: Digitalizing Access to Care: How Self-Check-In Kiosks Shape Access to Care and Efficiency of Hospital Services. NB. Het abstract en de fragmenten kunnen enigszins zijn aangepast ten behoeve van dit tentamen.

Lees het abstract van Loukili et al. en gebruik deze voor het beantwoorden van onderstaande vragen.

Abstract:

Introduction

Hospitals increasingly turn to self-check-in kiosks (*NL: aanmeldzuilen*) to streamline service delivery and improve patients' experiences. The purpose of this study was to reflect on the implementation of these self-check-in kiosks in a Dutch university hospital, particularly in relation to access to care for more vulnerable patients and intended efficiency goals.

Methods:

We carried out participatory observations, semi-structured interviews, and reflection sessions with developers and hospital staff. Data were analyzed through thematic analysis.

Results:
Our results show that although self-check-in kiosks work well for some patients, many people experience practical and psychosocial difficulties, especially those who go through a complex care pathway, are low-literate, experience a distance the online world, or have sensory, motor, or cognitive impairments. Kiosks are not yet attuned to these patients and typically leave little flexibility and room for negotiation and personal support in what is, for many, a foreign environment. Therefore, patients frequently seek confirmation and assistance from already downsized or busy staff. In conclusion, we find that digitalization under the banner of efficiency within a healthcare system already under pressure carries risks, as it can unintentionally generate extra (invisible) work for patients and care professionals and threaten access to and quality of care for patients most in need.

Conclusion
More attention for inclusion during the digitalization of healthcare processes contributes to fairer and more efficient care for all patients.

3. KWANTITATIEF VS. KWALITATIEF

In de studie van Loukili et al. kiezen de auteurs om op kwalitatieve wijze te onderzoeken hoe de aanmeldzuilen in het ziekenhuis gebruikt worden. Geef twee argumenten waarom een kwantitatieve studie *niet* geschikt zou zijn in deze casus. Beschrijf in je antwoord je methodologische overweging en betrek deze specifiek op de casus (4 punten).

Voorbeelden van correcte antwoorden:

- Inclusie van respondenten: De vragenlijst sluit mensen uit die je juist wilt includeren in een studie over digitale inclusie (bijvoorbeeld leesvaardigheid, digitale vaardigheden, digitale vragenlijst, etc.).
- Kwaliteit van de dataverzameling: De vragenlijst vraagt naar hoe mensen de implementatie ervaren, niet naar wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt (observaties zijn daarvoor nodig). Mensen zeggen niet altijd wat ze daadwerkelijk doen in de praktijk.
- Hypotheses toetsen: Je toetst geen harde hypotheses, maar kijkt naar het daadwerkelijke gebruik in de praktijk.
- Kwantitatieve methoden lenen zich minder goed om (diepgaande) ervaringen van de patiënten in kaart te brengen.
- Onzichtbaar werk (zie resultaten) van medewerkers wordt niet zichtbaar als je alleen kijkt naar meetbare uitkomsten (denk aan: aantal geslaagde aanmeldingen). Dit moet je op een kwalitatieve manier onderzoeken, bijvoorbeeld door interviews met medewerkers.

Let op: argumenten over de consequenties van het kiezen voor de kwalitatieve methode worden niet goed gerekend. Bijv. in deze studie gebruiken ze een thematische analyse dit kan niet met getallen.

4. PARADIGMA's

Eén van je medestudenten beweert op basis van dit abstract dat de onderzoekers vanuit een fenomenologisch paradigma werken. Jij twijfelt. Geef een argument waarom deze studie volgens jou niet fenomenologisch is en een argument waarom (delen van) deze studie wel fenomenologisch zouden kunnen zijn (4 punten)?

Niet: In de probleemstelling/analyse/resultaten ligt de nadruk niet op de geleefde ervaring van gebruikers, maar meer op de praktische gevolgen in het ziekenhuis. De analyse gaat over hoe

ongelijkheid vergroot wordt en duidt meer op kritische theorie (meer werkdruk, minder toegang tot zorg).
Niet: In de probleemstelling/analyse/resultaten ligt de nadruk niet op de geleefde ervaring van gebruikers, maar meer op de praktische gevolgen in het ziekenhuis. Ook wordt er een koppeling gemaakt naar sociale en politieke structuren (bijv. werkdruk personeel, kostenreductie). Dit wijst op sociaal-constructivisme.

Wel: In de interviews kan er wel degelijk ingegaan zijn op de geleefde ervaringen van de gebruikers/ontwikkelaars. Het onderzoek gaat over het fenomeen van de aanmeldzuil, en ze observeren de bodily experiences via observaties en bevragen mensen daarover in interviews.

ONDERZOEKZOEKSDOEL

Mortelmans onderscheidt vier belangrijke doelen van kwalitatief onderzoek: 1) exploratief, 2) verklarend, 3) beschrijvend en 4) emancipatorisch. Geef aan welk doel het onderzoek van Loukili et al. (2024) heeft (1 punt) en waar dit uit blijkt (1 punt).

Beschrijvend (1 punt): In de resultaten wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de case die bestudeerd wordt. Bij dit type kwalitatief onderzoek draait het om het in diepte begrijpen van de processen van betekenisgeving. (1 punt)

Uit mortelmans:

4.5.3 BESCHRIJVEND ONDERZOEK

Een derde doel dat aan kwalitatief onderzoek ten grondslag ligt, is het beschrijven. De waarde van het onderzoek hier is het aanleveren van een gedetailleerde beschrijving van een bepaalde case die bestudeerd wordt. Kwalitatief onderzoek gaat over het in de diepte begrijpen van processen van betekenisgeving en een van de wijzen om tot een dergelijk begrijpen te komen is het omstandig beschrijven van een case. De verantwoording in dit geval bestaat in de kennis en inzichten die de omstandige beschrijving van een bepaalde case kunnen bijdragen. Zeker wanneer de case een uniek geval is, is een nauwkeurige wetenschappelijke beschrijving een belangrijke meerwaarde.

5. ONDERZOEKSVRAAG

In het abstract wordt geen kwalitatieve onderzoeksvraag geformuleerd. Help de onderzoekers om hun abstract te verbeteren door twee mogelijke sub-vragen voor het onderzoek te bedenken die passend zijn. Een sub-vraag voor de 1) de interview-studie en een sub-vraag voor bij 2) de participerende observaties. (6 punten).

Voorbeelden van goede antwoorden:
1. Hoe ervaren patiënten en zorgprofessionals het gebruik van de zelfcheck-in kiosken?
2. Hoe interacteren patiënten met de self-check-in kiosken? Of: Wat zijn de gevolgen van de implementatie van de self-check-in kiosk in de zorgpraktijk?

Belangrijk dat studenten 3 elementen goed in de onderzoeksvraag zetten: ‘de doelgroep’, ‘de context’ en dat het een niet-gesloten vraag is die aansluit bij iets wat je kunt achterhalen via interviews (mondeling) en participerende observaties (zien).

6. ONDERZOEKSDESIGN

> Comprehensive understanding and triangulation of data were ensured by using a range of methods, including desk research, observations, interviews, and a final validation session (Figure 1). […] For contextual understanding, desk research was conducted by analyzing (internal) policy documents. During the participatory observations (total of 140 hours), researchers (authors of the present article) offered assistance and engaged in informal conversations with patients, employees, and volunteers in the hospital. Following exploratory observations, an observation schedule was developed to systematically record specific behaviors, such as searching for the self-check-in kiosks, handling these kiosks, searching for help or assistance, interacting with others, and the consequences of and emotions relating to these patients' behaviors. […] Semi-structured interviews (n = 14) were conducted with hospital staff consisting of policymakers (n = 5), team leaders (n = 3), desk employees (n = 3), a staff member, a volunteer, and an application developer by using purposive sampling (Gray, 2021). The 30- to 60-minute-long interviews were audio recorded and transcribed with participants' consent

Lees onderstaand stukje uit de methodesectie:

Zoals besproken in hoorcollege 3 (Karijn Aussems/Nicole Goedhart) zijn designs (of grondvormen) niet zo eenduidig als in kwantitatief onderzoek en kunnen termen per vakgebied verschillen. Ook in dit artikel zijn de auteurs niet heel expliciet over het design wat ze hanteren. Op basis van het abstract: Welk onderzoeksdesign hanteren de auteurs volgens jou? (1 punt) Geef aan op basis van welke informatie je deze conclusie trekt en noem daarbij ten minste twee kenmerken van dit design. (4 punten)

Kies uit: case studie, kwalitatieve survey, etnografisch studie of participatief actieonderzoek.

Case studie, te herkennen aan de volgende kenmerken:
Onderzoekobject: Het 'voorval' of 'phenomenon' in dit geval is de implementatie van de aanmeldzuilen.
Kennis: Het doel is het begrijpen van het voorval vanuit verschillende perspectieven, waarbij diverse stakeholders worden gesproken, zoals patiënten, ziekenhuispersoneel en ontwikkelaars.
Triangulatie van methoden: De methoden omvatten observaties, interviews en een groepssessie.
Doel: Het doel is illustratief en diepgaand, met een groot leereffect.

7. INTERVIEWS 1

Lees onderstaand stukje van een van de semigestructureerde interviews:

> [..]
> *Interviewer: "Kunt u iets vertellen over hoe patiënten reageren op de aanmeldzuilen bij binnenkomst?"*
> *Baliemedewerker: "Ja, over het algemeen zijn de reacties wisselend. Sommige patiënten vinden het heel handig, vooral de jongere mensen. Ze kunnen snel zelf hun afspraak bevestigen en dat scheelt hen tijd. Maar er zijn ook veel patiënten, vooral ouderen, die het lastig vinden. Ze zijn soms niet gewend om met touchscreens te werken of hebben moeite met het lezen van de instructies op het scherm."*
>
> *Interviewer: "Hoe gaat u om met mensen die moeite hebben met de zuilen?"*
>
> *Baliemedewerker: "Wij proberen hen zoveel mogelijk te ondersteunen. Meestal lopen we even mee en helpen we hen stap voor stap. Vaak is een eenmalige uitleg al voldoende, maar er zijn ook mensen die het steeds lastig*

blijven vinden. Voor die groep proberen we altijd bereikbaar te blijven, zodat ze zich niet ongemakkelijk voelen om het nog eens te vragen."

Interviewer: "Zorgt de introductie van deze aanmeldzuilen er niet voor dat uw werk onnodig gecompliceerd wordt?"

Baliemedewerker: "Ja, ik merk wel dat het werk is veranderd. Aan de ene kant ontlasten de zuilen ons, want sommige mensen kunnen zichzelf aanmelden zonder onze hulp. Maar aan de andere kant krijg ik inderdaad meer vragen, vooral in het begin, omdat niet iedereen direct snapt hoe het werkt. Het vraagt dus een balans tussen het uitleggen en het toezicht houden bij de balie."

[..]

Mortelmans zou de laatste vraag van de interviewer als niet-neutraal beschrijven. Beschrijf het risico van niet-neutrale vragen (1 punt) en herformuleer deze vraag naar een juiste vraag (1 punt).

Als interviewer moet je empathisch zijn ten opzichte van je respondent. De interviewer moet zich goed inleven en kan op basis van kennis (en vooroordelen) informatie invullen. Het gevaar is dat de interviewer hierdoor belangrijke informatie mist, omdat de respondent dan meegaat in de denkwijze van de interviewer (zie ook Mortelmans, p. 241).

Voorbeelden van goede vragen: Heeft u het gevoel dat de aanmeldzuilen uw werk hebben veranderd? Zijn er situaties waarin het werken met de aanmeldzuilen anders is dan werken zonder deze zuilen? Hoe beïnvloeden de aanmeldzuilen de manier waarop u patiënten te woord staat?

8. INTERVIEWS 2

In deze studie hebben de onderzoekers gekozen voor semi-gestructureerde interviews. Mortelmans noemt vier kenmerken van een semi-gestructureerd interview. Welk van de vier is NIET een kernmerk? (1 punt)

a. Face-to-face
b. Directieve stijl
c. Flexibel in aanpak
d. Interactief

9. METHODEN

De onderzoekers maken gebruik van “reflection sessions with developers and hospital staff”. In de projectgroep van het onderzoek is er discussie over de nut en noodzaak van deze sessies. Geef een argument waarom deze sessies belangrijk zijn en betrek in je argument kennis over het de maatschappelijke relevantie (of in termen van Mortelmans: de Praktische redenen) van dit onderzoek. (2 punten)

De **reflection sessions** met ontwikkelaars en ziekenhuispersoneel zijn van groot belang voor dit onderzoek, omdat zij een platform bieden voor kritische reflectie en gezamenlijke actie. Door de verschillende perspectieven van betrokkenen te combineren, kunnen praktische problemen en mogelijke verbeterpunten bij de implementatie van de technologie (zoals de aanmeldzuilen) beter

worden geïdentificeerd en aangepakt. Dit is essentieel voor het realiseren van maatschappelijke relevantie, omdat het onderzoek niet alleen gericht is op het begrijpen van de situatie, maar ook op het aansporen van verandering in de praktijk, die uiteindelijk de zorg voor patiënten kan verbeteren en werkdruk kan verlagen. De reflection sessions stimuleren deze verandering door continu te reflecteren op de effectiviteit van de implementatie en het verzamelen van waardevolle inzichten van alle betrokkenen, die cruciaal zijn voor het succes van het project en de maatschappelijke verbetering ervan.

10. POSITIONALITEIT

In strength- and limitation section staat:

> Finally, the first author's Moroccan background and proficiency in multiple languages facilitated communication with various patients from diverse backgrounds. This was well-received as "comfortable and pleasant," aiding in recognizing patients' questions, providing assistance, and providing space for more honest accounts of their experiences.

In het logboek van de auteur wordt nog veel uitgebreider stilgestaan bij zijn eigen rol in het onderzoek. Leg uit waarom het belangrijk is dat een onderzoeker kritisch op zijn of haar eigen positie in relatie tot het onderzoeksonderwerp en de deelnemers reflecteert (2 punten).

Het is belangrijk dat een onderzoeker kritisch reflecteert op zijn of haar eigen positie in relatie tot het onderzoeksonderwerp en de deelnemers, omdat de persoonlijke ervaringen, waarden, en sociale identiteit van de onderzoeker de manier waarop data wordt verzameld, geïnterpreteerd en gepresenteerd kunnen beïnvloeden. Door deze positie expliciet te erkennen, kan de onderzoeker de kwaliteit van het onderzoek versterken en zorgen voor een transparant onderzoeksproces.

Let op: punten aftrek bij het gebruik van het woord 'Bias'

11. WERVING

Een medestudent bekritiseert de studie omdat het onduidelijk is hoe respondenten geworven zijn. Formuleer twee adviezen voor de onderzoekers over hoe ze de werving voor participanten het beste vorm hadden kunnen geven. Let daarbij specifiek op de verschillende vormen van dataverzameling (interviews en participerende observaties) en betrek in je advies je kennis over de verschillende vormen van werving (hoorcollege 7, Barbara Groot en/of Mortelmans) in kwalitatief onderzoek (4 punten).

Advies 1: Werving voor participerende observaties
Bij participerende observaties is het belangrijk om te werken met gemak (convenience) sampling, waarbij respondenten gemakkelijk toegankelijk zijn. In dit geval kunnen onderzoekers deelnemers werven door mensen die langskomen in de omgeving van de aanmeldzuilen te observeren.

Advies 2: Werving voor interviews
Bij het werven van deelnemers voor diepgaande interviews is het belangrijk om doelgerichte wervingsstrategieën toe te passen, zoals maximum-variation sampling. Dit betekent dat de onderzoekers proberen een breed scala aan perspectieven te verkrijgen, door respondenten met verschillende ervaringen en achtergronden te selecteren.

12. ANALYSE I

In de alinea over analyse staat:

Data was analyzed, with the help of MAXQDA, through an thematic analysis.The themes “emerged” from the data through a process of open coding and theme refinement without restricting the analysis by predefined codes and themes Intermediate findings were used to adjust the interview guide and the observation schedule(Chapman et al., 2015). The quotes in the final manuscript were translated into English by the authors.

Op welke manier hebben de auteurs gecodeerd? (1 punt)

a) Afductief
b) Deductief
c) Abductief
d) Inductief

13. ANALYSE II

De thematische analyse volgens Braun & Clarke (2006) bestaat uit zes stappen. De eerste stap is ‘Familiarizing yourself with your data’. Beschrijf drie belangrijke activiteiten die je in deze fase moet uitvoeren om je vertrouwd te maken met de gegevens. (3 punten)

Volgens Braun & Clarke bestaat dit proces uit: Transcriberen, (actief) lezen en herlezen van de data, eerste ideeën noteren.

14. KWALITEIT 1

In de methodenparagraaf schrijven de onderzoekers:

For contextual understanding, desk research was conducted by analyzing (internal) policy documents. During the participatory observations (total of 140 hours), researchers (authors of the present article IL and NG) offered assistance and engaged in informal conversations with patients, employees, and volunteers in the hospital.

1 Wat is de methodologische term voor het gebruiken van diverse methoden binnen één onderzoek (1punt)?
2 Benoem twee specifieke kwaliteitscriteria van kwalitatief onderzoek waaraan dit bijdraagt. Leg uit. Kies uit: Geloofwaardigheid, overdraagbaarheid, afhankelijkheid, overtuigingskracht of authenticiteit. (2 punten)

De onderzoekers gebruiken verschillende vormen van dataverzameling. De methodologische term hiervoor is **data triangulatie**.

Geloofwaardigheid: De **geloofwaardigheid** (credibility) van het onderzoek wordt versterkt door triangulatie, waarbij verschillende vormen van dataverzameling worden ingezet om het onderwerp vanuit meerdere invalshoeken te onderzoeken. Door observaties, interviews en reflectiesessies te combineren, kan de onderzoeker de consistentie van de bevindingen nagaan en patronen of verschillen opsporen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de resultaten en zorgt ervoor dat deze een nauwkeurig en genuanceerd beeld van de werkelijkheid weergeven.
Overtuigingskracht: De **overtuigingskracht** (confirmability) wordt versterkt door de diverse methoden die in het onderzoek samenkomen. Dit criterium, dat ook kan worden gezien als **objectiviteit**, vraagt om

een kritische benadering van de onderzoekers en om transparantie in hoe zij de resultaten interpreteren. Door meerdere databronnen te gebruiken, kunnen de onderzoekers eventuele vooroordelen beter detecteren en hun bevindingen op een verantwoorde manier presenteren.

15. KWALITEIT 2

In het abstract wordt verder weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderzoek. Welke twee aanvullende maatregelen zouden de onderzoekers volgens jou minimaal moeten nemen? Benoem per maatregel hoe deze bijdraag aan de kwaliteit en wat de mogelijke uitdagingen kunnen zijn om deze maatregel specifiek in deze casus uit te voeren. (6 punten)

Voorbeeld van goede antwoorden:
Member check (1pt) bijvoorbeeld, draagt bij aan geloofwaardigheid omdat je kan checken of jou interpretatie van het informele gesprek of interview correct is (1pt), maar bij de participerende observaties is bijvoorbeeld lastig (1pt)

Thick description van de respondenten (1pt) kan bijdragen aan de kwaliteit omdat je goed inzicht hebt over wie je hebt gesproken (1pt), dit kan echter lastig zijn als je mensen maar kort kan spreken tijdens participerende observaties (1pt).

16. ETHIEK

Ethical Considerations
This study was evaluated by the Medical Ethical Review Committee of the Amsterdam University Medical Center (AUMC), location VUmc, the Netherlands, which confirmed that the Dutch Medical Research Involving Human Subjects Act did not apply.

In bovenstaand fragment wordt aangegeven dat het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van het Amsterdam UMC. Waar zou jij als lid van de ethische commissie op letten in de uitvoer van deze studie? Noem 2 punten. (4 punten)

Voorbeelden van goede antwoorden:

- **Covert observaties**: Als lid van de ethische commissie zou ik letten op het gebruik van covert observaties, waarbij deelnemers onbewust geobserveerd worden, wat ethisch problematisch kan zijn. Het is essentieel dat deelnemers expliciete toestemming geven, zodat hun recht op **informed consent** gewaarborgd is.
- **Anonimiteit en gegevensopslag**: Het is belangrijk dat alle persoonlijke gegevens van geïnterviewde deelnemers op een veilige manier worden opgeslagen en dat hun identiteit volledig geanonimiseerd wordt. De onderzoekers moeten garanderen dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en dat privacy wordt gerespecteerd.